RPE Nº25: Criterios Técnicos para el Proceso de Programación de Prestaciones de Cuidados Paliativos Universales

La Ley N.º 21.375[1] es la iniciativa legal que ampara el presente programa, vigente desde marzo de 2022 y que inicia su implementación de forma gradual en septiembre del mismo año. Como generalidades se destaca:

- Desde 2005 existe la cobertura de Cuidados Paliativos para personas con enfermedades oncológicas (GES N°4)[2]. Esta Ley otorga acceso y oportunidad de asistencia activa y seguimiento integral a personas con cáncer, dando alivio de los síntomas a las personas y sus familiares.
- Las personas beneficiarias de Cuidados paliativos no oncológicos fueron calculadas en base a un estudio de la Universidad Católica[3]. En éste, se estimó que cerca de 43.000 personas requerirían cuidados paliativos por enfermedades no oncológicas graves o terminales a lo largo del curso de vida.
- En la atención de Cuidados paliativos de personas con cáncer, destaca la creación de 29.398 casos nuevos en 2024[4].
- Los cuidados paliativos universales no discriminan sobre el origen de la condición de la persona, por lo que se debe considerar que incluye la atención de personas con necesidades paliativas en condición terminal o grave, ya sea de origen oncológico como no oncológico.

Personas beneficiarias:

- Personas con diagnóstico de cáncer, no progresivo o avanzado.
- Personas con enfermedades no oncológicas, graves o terminales.

Modelo de atención:

- El marco técnico de esta ley está dado por la Orientación Técnica de Cuidados Paliativos Universales, donde se detallan herramientas útiles para los clínicos en la evaluación de las personas, manejo de síntomas, aspectos psicosociales, entre otros[5].
- De acuerdo con el Decreto GES vigente, en el Problema de Salud N°4 “Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer” quedan incluidos todos los tipos de cáncer. Este problema de salud tiene por objetivo asegurar la máxima calidad de vida posible a las personas con diagnóstico oncológico, mediante el alivio y prevención de síntomas y del sufrimiento asociado a la enfermedad. Para acceder a esta garantía, la persona beneficiaria debe contar con confirmación diagnóstica del médico especialista, de esta manera accede al tratamiento, canasta descrita en el Listado Específico de Prestaciones GES.

---

[1] Ley Nº 21.375. Revisada el 03/07/2024, disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166846>

[2] Alivio del dolor por Cuidados paliativos y cáncer avanzado. Revisado el 03/07/2024, disponible en <https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/articles-18738_archivo_fuente.pdf>

[3] Javiera Léniz Martelli, Pedro Pérez Cruz, María Angélica Domínguez De Landa. Estudio estimación de demanda de población que requiere cuidados paliativos no oncológicos, informe II. Licitación ID: 757-134-L123. Abril 2024.

[4] Fuente: SIGGES, publicado en marzo 2025.

[5] Orientación técnica Cuidados paliativos universales. Revisado el 19/07/23, disponible en https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2023/01/Orientacion-Tecnica-Cuidados-Paliativos-Universales.pdf

- En el caso de personas con enfermedades no oncológicas, la detección puede ser en cualquier nivel de la red asistencial. Su seguimiento deberá quedar a cargo del Equipo de atención primaria (APS) o secundaria, según su nivel de complejidad. El modelo de atención puede ser revisado en detalle en el documento de Lineamientos para el modelo de atención de Cuidados paliativos universales en personas con enfermedades terminales o graves, disponible en la web[6].
- La visita domiciliaria es la estrategia preferencial para las personas que se benefician de CPU en APS; en la programación y la gestión de las agendas de los profesionales, se deben considerar los tiempos para realizar las visitas domiciliarias, incluyendo los traslados y la movilización. Se puede considerar la estrategia de atención remota, para control o seguimiento, el que puede ser de ayuda sobre todo para evaluar la respuesta al control de síntomas.
- Se sugiere la protocolización de sistemas de referencia y contrarreferencia, que favorezcan una comunicación fluida entre APS y nivel secundario, de manera de facilitar el correcto flujo de personas beneficiarias. Dichos protocolos deben ser realizados de acuerdo con la realidad territorial correspondiente.
- Dentro de este marco, los comités son una forma segura de sancionar conductas terapéuticas, igualmente con fines docentes y de apoyo técnico para los profesionales de APS con los especialistas del nivel secundario, o entre especialistas.
- El ingreso de personas con diagnóstico oncológico no deberá ser visto de manera exclusiva por el equipo de CPU de APS ni dar entrega de canasta farmacológica de su garantía GES 4, a excepción de los hospitales comunitarios y de establecimientos que tengan convenio de traspaso de la garantía GES 4 al nivel primario. Aquellas personas, que siendo beneficiarias del PADDS, cumplan los criterios y sean ingresadas a Cuidados Paliativos no oncológicos, podrán recibir prestaciones complementarias desde ambas estrategias, las que deben planificarse y coordinarse en forma conjunta, procurando que la población reciba cuidados organizados y continuos.

Criterios Técnicos para Cuidados Paliativos Universales en la APS

A continuación, se presentan las actividades que podrán realizarse en Cuidados paliativos universales de atención primaria, los que van en línea con actividades del REM A33 y con la Resolución exenta de programa.

ACTIVIDAD	PROFESIONAL (instrumento)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RENDIMIENTO	CONCENTRACIÓN	COBERTURA	OBSERVACIONES
Visita domiciliaria integral de ingreso	Médico cirujano Otro profesional equipo TENS	Primera visita domiciliaria que se realiza a la persona en cuidados paliativos, su cuidador y su entorno, dando origen a un plan de acción definido por el equipo de cabecera (Plan integral consensuado), con objetivos específicos que comandan las acciones promocionales, preventivas, terapéuticas y de rehabilitación a realizar. Es la primera que se realiza.	0,7 a 1	1	100% población bajo control	Considera registro, realización de recetas y referencia en los casos que lo requieran. No se considera el traslado. Los tiempos de movilización se deben ajustar de acuerdo con la territorialidad de cada centro.
Visita domiciliaria integral de seguimiento	Médico cirujano Otro profesional equipo TENS	Visita Domiciliaria de seguimiento que se realiza a la persona en cuidados paliativos, su cuidador y su entorno, dando origen a un plan de acción definido por el equipo de cabecera (Plan integral consensuado), con objetivos específicos que	1	Al menos 11 atenciones por año	100% población bajo control	Considera registro, realización de recetas y referencia en los casos que lo requieran. No se considera el traslado. Los tiempos de movilización se

[6] Lineamientos para el modelo de atención de Cuidados paliativos universales en personas con enfermedades terminales o graves. Revisado el 19/07/23, disponible en https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2023/01/Lineamientos-para-el-modelo-de-atencion-Cuidados-Paliativos-Universales.pdf

		comandan las acciones promocionales, preventivas, terapéuticas y de rehabilitación a realizar.				deben ajustar de acuerdo con la territorialidad de cada centro.
Visita domiciliaria tratamiento/ procedimiento /rehabilitación	Médico Otro profesional equipo TENS	Corresponde a las visitas domiciliarias que se realizan a la persona en cuidados paliativos, su cuidador y su entorno; para efectuar acciones de diagnóstico, tratamiento, procedimientos, recuperación y rehabilitación, etc. Contempla aquellas atenciones derivadas del plan de cuidados y aquellas requeridas según el curso de vida, plan de salud familiar, garantías o por requerimientos de atención de morbilidad.	1	Según necesidad del beneficiario/a	100% población bajo control	Considera registro, realización de recetas y referencia en los casos que lo requieran. No se considera el traslado. Los tiempos de movilización se deben ajustar de acuerdo con la territorialidad de cada centro.
Consulta nueva a persona	Médico cirujano Otro profesional equipo	Es la primera atención proporcionada por el equipo de salud a la persona en cuidados paliativos universales que comprende evaluación, diagnóstico, determinación del plan de acción. Se realiza en el centro de salud.	1	1	100% población bajo control	Considera entrevista a la persona beneficiaria y/o cuidador/a, registro, realización de recetas y referencia en los casos que lo requieran. Para personas que puedan asistir a su centro y en reemplazo a visita en domicilio de ingreso.
Control de seguimiento	Médico cirujano Otro profesional equipo	Es la atención de seguimiento proporcionada por el equipo de salud a la persona en cuidados paliativos universales que comprende reevaluación diagnóstica, determinación o modificación del plan de acción, ejecución de acciones de acuerdo con el plan, registro y citación a nuevas consultas en caso de necesidad. Se realiza en el centro de salud.	2	Según necesidad del beneficiario/a	100% población bajo control	Considera entrevista a la persona beneficiaria y/o cuidador/a, registro, realización de recetas y referencia en los casos que lo requieran. Para personas que puedan asistir a su centro y en reemplazo a visita en domicilio.
Consulta abreviada ambulatoria	Médico cirujano Otro profesional equipo	Corresponde a una atención de duración acotada, en que no existe evaluación profesional completa de la persona. Su solicitud, es mediante atención directa de la persona beneficiaria o su cuidador/a en el centro de atención.	4	Según necesidad del beneficiario/a	100% población bajo control	Pueden considerarse en esta consulta la realización de documentos, recetas u otra acción abreviada.

Atención ambulatoria a familiares	Médico cirujano Otro profesional equipo	Es la intervención ambulatoria realizada por el profesional y/o técnico de enfermería. Esta intervención puede ser realizada tanto a familiares y/o cuidadores en relación con el plan de cuidado de la persona ingresada a cuidados paliativos o una acción directa al familiar o cuidador, de carácter educativo o intervenciones psicosociales. Incluye consejería, elaboración o evaluación del plan de cuidados, control y seguimiento para evolución, evaluación y psicoeducación, entre otras actividades definidas en las Orientaciones Técnicas.	2	Según necesidad del beneficiario/a o del/la familiar o cuidador/a	100% población bajo control	No considera una evaluación completa de la persona.
Teleconsulta	Médico cirujano Otro profesional equipo	Se refiere a la actividad sincrónica de interacción entre un profesional de la salud y un paciente, para dar una atención diagnóstico o terapéutico mediante medios electrónicos. Durante la teleconsulta podrían participar otros miembros del equipo de salud que se encuentran físicamente al lado de la persona atendida, acompañando o facilitando la atención.	3	Según necesidad del beneficiario/a	100% población bajo control	No considera una evaluación completa de la persona. No es posible homologar rendimiento a consulta presencial. En esta actividad se deben registrar los controles telefónicos.
Consulta abreviada remota	Médico Otro profesional	Corresponde a la ejecución de acciones de duración acotada, en que no existe atención profesional directa que implique evaluación completa de la persona. Su solicitud es desde la persona beneficiaria o su cuidador/a usando un medio electrónico.	4	Según necesidad del beneficiario/a	100% población bajo control	Pueden considerarse en esta consulta la realización de documentos, recetas u otra acción abreviada.
Autocuidado equipos	Todo el equipo de Cuidados paliativos universales	Espacio planificado de autocuidado del equipo de CPU, con el objetivo de tratar temáticas relevantes con la salud mental de sus participantes en el contexto de la atención de personas con sufrimiento o cercanas a la muerte.	0,25	Al menos 1 por semestre	100% equipo CPU	Reunión de 4 horas cronológicas de duración, al menos 2 veces al año. Es sugerible la búsqueda de más instancias de autocuidado del equipo.

Gestión de casos	Gestor/a de centro	Corresponde a las actividades de gestión con el fin de organizar las prestaciones del programa tales como agendamiento de posibles beneficiarios/as para ingreso, agendamiento de personas ingresadas para control, entre otros.	2 h/ semana si centro con 20 o menos beneficiarios/as 4 h/ semana si centro con 21-40 beneficiarios/as 5 h/ semana si centro con 41-80 beneficiarios/as 6 h/ semana si centro con 81 o más beneficiarios/as	--	100% población bajo control	El gestor/a del centro debiese tener una combinación de actividades clínicas y de gestión.
Comité	Gestor/a centro Médico/a que presenta Otros profesionales según realidad local	Realizar seguimiento de beneficiarios/as con complejidad intermedia, consultas a especialistas sobre el ingreso de beneficiario/a o consultas sobre el seguimiento, entre otros.	4	6	100% población bajo control	La periodicidad de las reuniones de comité deberá ajustarse a realidad local, se sugiere realizar cada 1 o 2 semanas.
Reunión clínica	Todos los profesionales de la salud que participen en atención de personas en CPU	Instancia de evaluación clínica y administrativa de casos de personas en CPU entre profesionales de un mismo equipo con el fin de tomar decisiones terapéuticas consensuadas.	2-3	12	100% población bajo control	Duración 60 minutos por semana.

Criterios Técnicos para Cuidados Paliativos Universales en Hospitales y Establecimientos de Especialidad

Las prestaciones que cada hospital y establecimiento ambulatorio de especialidad programe deben ajustarse a su cartera de servicios, en base a su rol en la red de cuidados paliativos universales del Servicio de Salud al que pertenece y al Modelo de Atención de Cuidados Paliativos Universales vigente.

En relación a las personas con enfermedad no oncológica, que sean vistas en los hospitales y establecimientos ambulatorios que cuentan con especialidad y que darán respuesta a casos complejos y altamente complejos según las OOTT de CPU vigentes[3], programarán principalmente prestaciones de médico y enfermera, dando énfasis a la coordinación con el nivel primario de atención que realizará la mayor parte de las atenciones presenciales a los pacientes (en la institución o en el domicilio).Los hospitales de baja complejidad que en modalidad ambulatoria cumplen un rol como prestador en el nivel primario de atención programarán las prestaciones definidas para dicho nivel de atención según el Modelo de Cuidados Paliativos vigente.

Actualmente el modelo de CPU para los niños, niñas y adolescentes está focalizado en la atención de los niveles secundario y terciario. Sin embargo, debiese avanzar paulatinamente en la capacitación y formación de los equipos de salud de la atención primaria, para adecuarse al modelo de CPU orientado a la atención domiciliaria de este grupo etario.

Respecto a las personas con enfermedad oncológica, serán ingresadas en los establecimientos de mayor complejidad de su territorio (Hospitales, CDT o CRS) y podrán ser derivadas a hospitales familiares y comunitarios, de acuerdo con su realidad territorial y el mapa de referencia y contrarreferencia de su Servicio de Salud. Excepcionalmente, podrán ser derivadas de manera exclusiva a la APS, donde exista convenio de traspaso de la garantía GES 4 al nivel primario. De acuerdo con lo descrito en el modelo de atención, las personas con enfermedades oncológicas ingresadas a cuidados paliativos, podrá recibir una atención complementaria en el nivel primario, lo que no implica la entrega de la canasta de tratamiento garantizado por el GES 04.

Los siguientes estándares recomendados constituyen un promedio del tiempo utilizado para cada prestación y son aplicables en la programación de la actividad clínico asistencial presencial (ambulatoria, cerrada, domicilio) y/o a distancia de hospitales y/o centros de especialidad.

La definición de las prestaciones vinculadas a la atención de personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave o terminal (oncológica o no oncológica) están contenidas en el manual REM A33 vigente.

ACTIVIDAD	PROFESIONAL (instrumento)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RENDIMIENTO	CONCENTRACIÓN	COBERTURA	OBSERVACIONES
Visita Domiciliaria consulta nueva	Médico/a Enfermera/o Psicólogo/a Trabajador social Nutricionista Fonoaudiólogo/a Kinesiólogo Terapeuta Ocupacional Técnico en Enfermería de Nivel Superior Conductor	Primera visita en domicilio para evaluación integral, educación y tratamiento del usuario/a, su familia y cuidador/a en Cuidados Paliativos universales.	0,7-1	Según necesidad del beneficiario/a	Pacientes de alta complejidad	No se considera el traslado. Los tiempos de movilización se deben ajustar de acuerdo con la territorialidad de cada centro.
Visita Domiciliaria consulta control	Médico/a Enfermera/o Psicólogo/a Trabajador social Nutricionista Fonoaudiólogo/a Kinesiólogo Terapeuta Ocupacional Técnico en Enfermería de Nivel Superior Químico farmacéutico Conductor	Visita en domicilio para seguimiento de evaluación integral, educación y tratamiento del usuario/a, su familia y cuidador/a en Cuidados Paliativos universales.	1	Según necesidad del beneficiario/a	Pacientes de alta complejidad	No se considera el traslado. Los tiempos de movilización se deben ajustar de acuerdo con la territorialidad de cada centro.
Consulta nueva a persona	Médico/a Otro profesional	Es la primera atención generada por un episodio de una enfermedad, mediante la que se puede o no dar resolución a un problema de salud. Se realiza en el	1	--	Pacientes de alta complejidad	

		centro.				
Consulta control a persona	Médico/a Otro profesional	Es la atención de seguimiento proporcionada por el profesional, comprende evaluación, diagnóstico, determinación o modificación del plan de acción, ejecución de acciones de acuerdo con el plan, registro y citación a nuevas consultas en caso de necesidad.	2	Según necesidad del beneficiario/a	Pacientes de alta complejidad	
Consulta abreviada ambulatoria	Médico/a Otro profesional	Corresponde a una atención de duración acotada, en que no existe evaluación profesional completa de la persona. Su solicitud, es mediante atención directa de la persona beneficiaria o su cuidador/a en el centro de atención.	4	Según necesidad del beneficiario/a	Pacientes de alta complejidad	Pueden considerarse en esta consulta la realización de documentos, recetas u otra acción abreviada.
Atención ambulatoria a familiares	Médico/a Otro profesional	Es la intervención ambulatoria realizada por el profesional y/o técnico de enfermería. Esta intervención puede ser realizada tanto a familiares y/o cuidadores en relación con el plan de cuidado de la persona ingresada a cuidados paliativos o una acción directa al familiar o cuidador, de carácter educativo o intervenciones psicosociales. Incluye consejería, elaboración o evaluación del plan de cuidados, control y seguimiento para evolución, evaluación y psicoeducación, entre otras actividades definidas en la Orientaciones Técnicas	2	Según necesidad de la familia del beneficiario/a	Pacientes de alta complejidad	No considera una evaluación completa de la persona
Teleconsulta	Médico, Enfermera, Psicólogo, Kinesiólogo, T. Ocupacional, Nutricionista, T. social, Q. farmacéutico	Se refiere a la actividad sincrónica de interacción entre un profesional de la salud y un paciente, para dar una atención diagnóstico o terapéutico mediante medios electrónicos. Durante la teleconsulta podrían participar otros miembros del equipo de salud que se encuentran físicamente al lado de la persona atendida, acompañando o facilitando la atención.	3	-	Pacientes de alta complejidad	No considera una evaluación completa de la persona. No es posible homologar rendimiento a consulta presencial. En esta actividad se deben registrar los controles telefónicos.
Consulta abreviada remota	Médico Otro profesional	Corresponde a la ejecución de acciones de duración acotada, en que no existe atención profesional directa que implique evaluación completa de la persona. Su solicitud es desde la persona beneficiaria o su cuidador/a usando un medio electrónico.	4	Según necesidad del beneficiario/a	Pacientes de alta complejidad	
Interconsulta en sala	Médico especialista	Corresponde a la atención profesional otorgada por el	1	Según necesidad	100%	

	Otro profesional	médico especialista u otros profesionales no médicos a una persona en un evento de hospitalización que incluye anamnesis, examen físico, prescripción de exámenes o intervenciones terapéuticas. Se aplica a establecimientos con atención médica de especialidades: Centro Diagnóstico Terapéutico (CDT), Centro Adosado de Especialidades de hospitales (CAE), Centro Referencia Salud (CRS). También se pueda poner en práctica en hospitales de menor complejidad con un equipo de Cuidados paliativos constituido.		del beneficiario/a		
Atención en sala	Médico especialista	Corresponde a la atención profesional otorgada por el médico especialista a persona beneficiaria en un evento de hospitalización que incluye anamnesis, examen físico, prescripción de exámenes o intervenciones terapéuticas. Se aplica a establecimientos con personas hospitalizadas, en donde los médicos de cuidados paliativos son los tratantes de las personas beneficiarias.	1 o 2	Según necesidad del beneficiario/a	100%	Utilizar rendimiento de 1 persona por hora en caso de intervenciones de mayor complejidad, donde además de realizar control de síntomas se realice una reunión familiar para entrega de información o toma de decisiones al final de la vida.
Gestión de casos	Gestor/a	Corresponde a actividades de gestión con el fin de organizar las prestaciones del programa tales como gestión de interconsultas para ingreso a primera atención o agendamiento de personas ingresadas para control, entre otros.	3 a 5 horas semanales	--	--	Ajustar de acuerdo con realidad local.
Comité	Médico, Enfermera, Psicólogo, Kinesiólogo, T. Ocupacional, Nutricionista, T. social, Q. farmacéutico	Corresponde a las intervenciones realizadas en tiempo real entre profesionales de salud del nivel secundario o entre profesionales de salud desde las unidades de especialidad hacia la APS, a través de Hospital Digital u otra estrategia local, con el objetivo de evaluar casos complejos.	4	12	Pacientes de alta complejidad	Al menos una vez al mes o cuando sea necesario. De acuerdo con realidad local. Se espera ejecución de mayor frecuencia, idealmente semanal.
Autocuidado equipos	Todo el equipo de Cuidados paliativos universales	Espacio planificado de autocuidado del equipo de CPU, con el objetivo de tratar temáticas relevantes con la salud mental de sus participantes en el contexto de la atención de personas con sufrimiento o cercanas a la muerte.	0,25	Al menos 1 por semestre	100% equipo CPU	Reunión de 4 horas cronológicas de duración, al menos 2 veces al año. Es sugerible la búsqueda de más instancias de autocuidado del equipo.